

УДК: 616.24-006.6-08 \

А.А. Бейсебаев, Э.Т. Баймухаметов, М.И. Карасаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, РК

Опыт выполнения одномоментной двусторонней лимфодиссекции при раке легкого

Рак легкого представляет чрезвычайно важную проблему для здравоохранения и населения Республики Казахстан. Актуальным является поиск и разработка наиболее патогенетически обоснованных методов оптимизации хирургического лечения, путем внедрения функционально-сберегающих операций, расширения зон лимфодиссекции в сочетании с химиолучевой терапией.

В последние годы разрабатываются проблемы органосохраняющего лечения рака легкого. В отличие от реконструктивно-пластических операций резекции легкого стали выполняться с эндовидеоторакоскопической поддержкой [Лемехов В. Г., 2005]. Всемирный опыт резекции легкого и одномоментной двусторонней внутригрудной лимфодиссекции путем торакотомии или срединной стернотомии состоит из единичных операций [Давыдов М. И., Полоцкий Б. Е., 2003; Mokoto Y., 2003; Hata E., 2004]. Принимая во внимание эту направленность в торакальной онкохирургии при резекции легкого предлагается производить лимфодиссекцию и контралатеральной грудной полости методом эндовидеоторакоскопии.

Цель работы - повышение эффективности лечения немелкоклеточного рака легкого

Объектами исследования были больные раком легкого.

Обследование включало традиционные исследования (рентгенологические методы, ФБС, трансторакальные пункционные биопсии).

Методы лечения: хирургический (удаление пораженной доли легкого, всего легкого с лимфодиссекцией и видеоассистированной контралатеральной внутригрудной лимфодиссекцией) и адъювантная ПХТ по показаниям.

Операция выполняется последовательно в два этапа. Сначала производится лимфодиссекция со здоровой стороны с односторонней вентилизацией, при этом пациент укладывается на пораженную сторону. Затем поворот на здоровый бок и выполняется из торакотомного доступа долевая резекция (лоб- или билобэктомия) или пневмонэктомия с лимфодиссекцией. Мы остановились именно на такой последовательности выполнения данного оперативного вмешательства, так как после выполнения лоб- или билобэктомии оставшиеся доли (доли) могут не обеспечить потребность организма в кислороде. Но с другой стороны имеется вероятность того, что после выполнения лимфодиссекции на стороне не пораженного легкого основной процесс будет признан не резектабельным.

Лимфодиссекция носит тотальный характер – удаляются все группы лимфатических узлов с обеих сторон.

Благодаря отдельной интубации легкое на стороне эндовидеоторакоскопической лимфодиссекции выключается из дыхания. Спавшиеся и неподвижное легкое обеспечивает пространство и создает оптимальные условия для выполнения манипуляций. Хирургические манипуляции производятся преимущественно из 4-х точек с миниторакотомным доступом. Данный доступ позволяет

комбинированное использование инструментов (для открытых операций и торакоскопических), что значительно облегчает выполнение манипуляций в плевральной полости. Выведение увеличенного изображения на монитор так же облегчает задачу хирурга.

Операции выполнены 24 пациентам. Возраст больных колебался от 42 до 65 лет. Соотношение лиц мужского и женского пола 6:1. У 10 больных патологический процесс локализовался слева, у 14 – справа.

Больным выполнены следующие объемы оперативных вмешательств.

Таблица – Объем оперативных вмешательств

Резекция легкого и двусторонняя лимфодиссекция	Кол-во больных	
	абс.	%
Верхняя лобэктомия справа	7	29,2
Средняя лобэктомия справа	1	4,2
Нижняя билобэктомия справа	6	25,0
Верхняя лобэктомия слева	6	25,0
Нижняя лобэктомия слева	2	8,3
Пневмонэктомия слева	2	8,3
Всего	24	100,0

По данным гистологического исследования послеоперационных препаратов поражения контралатеральных лимфатических узлов выявлено в одном случае.

Методика двусторонней лимфодиссекции с использованием видеоассистированной техники является щадящей так как не производится вскрытие обеих плевральных полостей. Послеоперационные осложнения сведены к минимуму. Летальность отсутствует.

Адекватность выполнения двусторонней лимфодиссекции подтверждается гистологическим методом исследования.

Состояние внутригрудных лимфатических узлов является основным фактором прогноза хирургического лечения больных. При гистологическом подтверждении вовлечения в опухолевый процесс лимфатических узлов следует проводить адъювантную химиотерапию.

Список литературы

1. Hata E., Ikeda Sh., Kavano R., Yokota T. Системная двусторонняя медиастинальная лимфодиссекция по поводу рака легкого стернотомным доступом: Докл. // Российско-японская международная конференция «Стратегия лечения рака легкого в XXI веке: что мы должны сделать сейчас и в будущем». Рос. онкол. научн. центр. - М., 2004. - № 4. - С. 101-104.
2. Mokoto Y., Nobuo O., Naoki I. et al. Проблема двусторонней медиастинальной лимфодиссекции при раке легкого // Haigan. Jap. J. Lung Cancer. - 2003. - 43. № 2. - P. 121-130.
3. Давыдов М. И., Полоцкий Б. Е. Современные принципы выбора лечебной тактики и возможности хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого // Новое в

терапии рака легкого (терапия рака легкого начала XXI века): Рос. онкол. науч. центр. М., 2003. - С. 41-53.

4. Лемехов В. Г., Барчук А. С., Клеменко В. Н. Эндовидеоторакоскопия в онкологической практике // СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. - 144 с.

Тұжырым

А.А.Бейсебаев, Э.Т.Баймұхамедов, М.И.Карасаев

Өкпенің қатерлі ісігі кезіндегі бір мезетті екі жақта лимфодиссекцияны орындаудағы тәжірибесі Қазақстан Республикасы тұрғындары және денсаулық сақтау ісі үшін өкпе қатерлі ісігін білу маңызы зор.

Жұмыс мақсаты: өкпе қатерлі ісігі ұсақ жасушалы емес түріндегі ем нәтижесін арттыру.

Ота кезекті 2 кезеңмен жүргізіледі. Алғашында лимфодиссекция сау жағына жасалады, сосын бөліктік резекциялар лоб- немесе билобэктомия немесе зақымдалған өкпенің лимфодиссекциямен бірге пневмонэктомиясы жасалады.

Лимфодиссекция жалпылама сипатта болады.

Ота 24 науқасқа жасалынды. Науқастардың жас аралығы 42 мен 65 жаста.

Ер адамдармен әйел адамдар ара – қатынасы 6:1. 10 науқаста үрдіс сол жағында, 14 де оң жағында орналасты. Операциядан кейінгі асқынулармен өлім бұл науқастар арасында болмады. Гистологиялық зерттеулер нәтижесіне байланысты қарама-қарсы жақтың лимфа түйіндерінің зақымдалуы бір науқаста болды.

Видео көмекпен бірге жасалынған 2 жақты лимфодиссекция отасы мүше сақтаушы оталарға жатады.

Екі жақты лимфодиссекция отасының нәтижелілігі гистологиялық тексеру әдісімен нақтыланады.

Кеуде ішілік лимфа түйіндері жағдайы науқастардың

хирургиялық отадан кейінгі болжамына көп әсер етеді.

Түйінді сөздер ұсақ клеткалы емес өкпенің қатерлі ісігі, екі жақта лимфодиссекция.

Summary

A.A.Beysebaev, E.T.Baimukhametov, M.I.Karasayev

Experience in performing simultaneous bilateral lymphadenectomy in lung cancer Lung cancer is an extremely important issue for the health and population of the Republic of Kazakhstan. In recent years, developed organ preservation treatment of lung cancer.

Objective: To increase the effectiveness of treatment non-small cell lung cancer Operations are performed in two stages. First the dissection with a healthy side, then lobar resection (forehead or bilobectomy) or pneumonectomy with lymph node dissection of the affected lung. LND is total.

Surgery was performed 24 patients. Age of patients ranged from 42 to 65 years. The ratio of male and female 6:1. In 10 patients the pathological process was localized to the left, 14 - on the right.

Postoperative complications and mortality in this group of patients were observed. According to the histological study of post-operative medications lesions of contralateral lymph nodes was noted in one case.

1. Using bilateral videoassisted lymphadenectomy technique is sparing. Mortality is missing.

2. Properly executed bilateral lymphadenectomy confirmed by histological studies.

3. Hilar lymph node status is a major predictor of surgical treatment.

Keywords: non-small cell lung cancer, bilateral lymphadenectomy.